UE B2 · SEMESTRE 1 · COURS ET NOTES DE SÉANCE

PSYCHOLOGIE DE LA SANTÉ

Fiche de révision écrite

Cours de Mme Nathalie Khatir : documents officiels 1, 2 et 3. La fiche conserve les 59 définitions de la version précédente et complète les thèmes utiles aux partiels, sans confondre associations historiques et causalités médicales.

Pourquoi cette fiche ?

Comprendre la santé et la maladie à travers le vécu de la personne, ses représentations, ses ressources et son environnement ; analyser un témoignage en définissant et en justifiant précisément les concepts utiles.

Priorité annoncée pour les partiels

Les définitions doivent être rédigées intégralement, sous forme de phrases complètes (sujet, verbe et complément). Une suite de mots-clés ou une formulation tronquée ne suffit pas. Dans un témoignage clinique, il faut savoir identifier les notions pertinentes, les définir et justifier précisément leur application.

Comment utiliser cette fiche

Premier passage : lire le déroulé conceptuel. Deuxième passage : appliquer les notions aux situations de patients. Avant l'évaluation : relire la section « Pièges QCM », la synthèse puis mémoriser les définitions complètes du lexique final.

Une démarche pour analyser un témoignage

1 · Repérer	Identifier les faits et les paroles de la personne.
2 · Nommer	Choisir précisément les concepts pertinents.
3 · Définir	Donner une définition intégrale, en phrases complètes.
4 · Justifier	Relier la notion aux faits du témoignage.
5 · Nuancer	Éviter les conclusions automatiques et les causalités abusives.

Sommaire rapide — accès aux chapitres

Fondamentaux et qualité de vie	2–5	Maladie, douleur et souffrance	6–9
Modèles et événements de vie	10–12	Soutien social et personnalité	13–18
Stress, coping et défenses	16–23	Annonce et corps vécu	23–27
Méthode d'analyse	26–29	Pièges QCM et synthèse	30
Définitions et mots-clés	31–39		

Réflexe de partiel

Dans un témoignage : repérer les faits → nommer la notion → la définir intégralement → justifier son application → nuancer l'interprétation.

Plan de révision

Fiche enrichie à partir des trois documents officiels de Mme Khatir et des contenus de la fiche antérieure.

01 Objectifs et méthode
02 Fondamentaux, santé et qualité de vie
05 Comprendre et évaluer la qualité de vie
06 Maladie, représentations, douleur et souffrance
08 Définitions générales et expérience douloureuse
10 Modèles de santé et événements de vie
13 Soutien social et son évaluation
15 Vulnérabilité, résilience et personnalité
19 Stress, coping et mécanismes de défense
20 Selye, transaction et ajustement en situation
22 Défenses : cadre théorique et distinctions
23 Annonce du diagnostic et réactions possibles
24 Corps vécu et identité corporelle
26 Méthode et application à un témoignage
30 Pièges QCM et synthèse générale
31 Définitions et mots-clés — 01 à 59
38 Définitions complémentaires — 60 à 71
39 Définitions générales — 72 et 73

01 · Fondamentaux : santé, maladie et qualité de vie

La psychologie de la santé étudie les déterminants biologiques, psychologiques, sociaux et environnementaux de la santé, de la maladie et des comportements de santé. Elle s'intéresse au sens donné par la personne à son état et à la manière dont elle traverse le soin, la prévention, l'annonce, la douleur ou le handicap.

À retenir : ne pas confondre concept théorique, expérience subjective du patient et interprétation du soignant : ces trois dimensions éclairent la situation, sans se substituer les unes aux autres.

Dans un témoignage, ne pas déduire le vécu psychique du seul diagnostic. Demander ce que la maladie **signifie** pour la personne, ce qu'elle lui fait perdre et quelles ressources elle mobilise.

Santé : modèle global et dynamique

La définition de l'OMS citée dans le cours envisage la santé comme un état de complet bien-être physique, mental et social, au-delà de l'absence de maladie. Le cours interroge les limites d'un « complet bien-être » difficile à atteindre et insiste sur une vision évolutive : équilibre, capacités de satisfaire les besoins, ressources individuelles et sociales et adaptation au milieu.

Conception	Ce qu'elle permet de comprendre
Biomédicale	État biologique, atteintes, symptômes, diagnostic et traitement.
Globale / biopsychosociale	Interactions entre le corps, le vécu psychologique, les relations, la culture et les conditions de vie.
Dynamique et subjective	La santé change dans le temps et dépend aussi de la manière dont la personne évalue ses propres possibilités.

Le modèle des besoins de Maslow est mobilisé à titre de repère : besoins physiologiques, sécurité, appartenance/affection, estime et accomplissement. La maladie peut modifier simultanément plusieurs besoins.

Santé perçue et qualité de vie

La **santé perçue** correspond à l'auto-évaluation de sa santé physique et psychique. La qualité de vie intègre aussi l'autonomie, les relations, la place sociale et les conditions environnementales. Une personne atteinte d'une maladie chronique peut déclarer une qualité de vie satisfaisante ; à l'inverse, l'absence d'atteinte somatique identifiée ne garantit pas un bien-être vécu.

Domaines de qualité de vie	Repères
Physique	Douleur, mobilité, fatigue, sommeil, effets du traitement, énergie.
Psychologique	Émotions, humeur, estime de soi, mémoire, concentration, vécu de l'avenir.
Social	Liens, soutien, vie familiale, activités, travail, place dans les groupes.
Environnement et autonomie	Logement, sécurité, ressources financières, accès aux soins, liberté d'action.

EN PRATIQUE

Distinguer l'évaluation extérieure de la santé (**hétéro-évaluation**) de la perception du patient (**auto-évaluation**). Éviter de corriger le vécu du patient avec de seuls résultats médicaux.

Repères initiaux : objectifs, histoire et qualité de vie

Lire la santé et la maladie à travers le vécu d'une personne, ses ressources et son environnement.

Les objectifs d'apprentissage du cours

Le cours demande de connaître les fondements et concepts-clés de la psychologie de la santé, de comprendre le sens de la maladie pour le patient et ses proches, de distinguer douleur, souffrance et souffrance psychique, et d'expliquer pourquoi l'apparition ou l'évolution d'une même maladie varie selon les personnes.

Pourquoi la psychologie de la santé s'est-elle développée ?

La psychologie de la santé mobilise les connaissances psychologiques pour étudier la prévention, les comportements de santé et le vécu des maladies. Le support mentionne la constitution, aux États-Unis en 1979, d'une section « Health Psychology » au sein de l'American Psychological Association. Il insiste sur l'intérêt de considérer la personne, ses relations et les dimensions biologiques, psychologiques et sociales ensemble.

Ses champs d'application concernent notamment la promotion de la santé, les comportements à risque, les maladies chroniques et l'accompagnement des patients au sein des établissements de santé et dans d'autres milieux de vie.

La qualité de vie : quatre dimensions, mais plusieurs manières de la mesurer

La qualité de vie renvoie à la perception subjective qu'une personne a de son existence dans son contexte culturel et au regard de ses attentes. Ses quatre grands domaines dans le cours sont la santé physique et les capacités fonctionnelles, l'état psychologique, les relations sociales et l'environnement. On peut utiliser des questionnaires généraux ou adaptés à une pathologie ; les résultats dépendent de l'outil, du contexte et du point de vue de la personne.

Dimension	Questions de soin utiles
Physique	Fatigue, douleur, mobilité, autonomie et sommeil
Psychologique	Bien-être, émotions, estime de soi, concentration et projet de vie
Sociale	Relations, famille, travail, sentiment d'appartenance et soutien
Environnementale	Logement, ressources, sécurité, accès aux soins et déplacements

Exemple : après un diagnostic de diabète, une personne peut rapporter une bonne autonomie quotidienne mais une forte inquiétude liée à l'avenir. Le diagnostic et les chiffres biologiques ne résument donc pas sa qualité de vie.

Comprendre la santé et la qualité de vie

La psychologie de la santé articule trois axes : la santé et sa préservation, la maladie et ses déterminants, puis la personne malade et son vécu. Elle contribue à la promotion et à la prévention, à la compréhension de la maladie et à l'accompagnement des soins. Les dimensions biologiques, psychologiques, sociales et environnementales interagissent.

Les conceptions de la santé ont évolué : d'un état idéal complet vers une ressource de la vie quotidienne, un équilibre et une capacité d'adaptation. Un diagnostic ne résume donc pas à lui seul l'état de santé vécu. Le contexte, les capacités d'action et les possibilités de participation comptent aussi.

Évaluer une qualité de vie singulière

Approche	Ce qu'elle apporte et ses limites
Générique	Des outils tels que le WHOQOL permettent d'explorer plusieurs domaines de vie dans des populations différentes : physique, psychologique, relations sociales et environnement. Le WHOQOL-BREF en est une forme courte.
Spécifique	Un questionnaire propre à une pathologie, tel que l'EORTC en cancérologie, détaille les dimensions particulièrement concernées par cette maladie et ses traitements.
Auto-évaluation	La personne évalue son propre vécu. Son appréciation ne se confond ni avec les résultats biologiques ni avec le jugement d'un observateur.
Hétéro-évaluation	Un professionnel ou un proche apporte un autre point de vue. Il peut sous-estimer certains symptômes ou l'impact sur la vie quotidienne ; les écarts avec le récit du patient sont à explorer.

Situation de soin

Un traitement peut améliorer un indicateur somatique tout en limitant des activités essentielles pour la personne. Demander ce qu'elle souhaite préserver permet de comprendre sa qualité de vie et d'en parler avec l'équipe ; cela ne conduit pas à modifier soi-même le traitement.

Besoins et contexte

La maladie peut toucher simultanément les besoins physiologiques, la sécurité, l'appartenance, l'estime et l'accomplissement. La liste de Maslow sert ici à élargir le questionnement ; elle ne remplace pas l'écoute de la priorité réelle du patient. Les exemples chiffrés anciens du cours illustrent des écarts de vécu, sans décrire automatiquement la population actuelle.

02 · Vivre la maladie : plainte, douleur et représentations

Trois dimensions complémentaires de la maladie

Terme	Dimension	Question dans un témoignage
Disease	Maladie comme objet biomédical.	Quels signes, lésions, mécanismes et diagnostics ?
Illness	Expérience subjective de la maladie.	Que ressent et raconte la personne ?
Sickness	Dimension sociale de la maladie.	Comment est-elle reconnue, accueillie, stigmatisée dans son milieu ?

La maladie chronique peut modifier durablement le rapport à soi, l'autonomie, le projet de vie et l'organisation familiale. Le handicap s'envisage aussi sous l'angle des restrictions de fonctionnement et de participation, en plus des atteintes corporelles.

Douleur, souffrance et plainte ne sont pas synonymes

La douleur est abordée comme une expérience sensorielle et émotionnelle personnelle. La perception de la douleur ne se déduit pas mécaniquement d'une lésion : une douleur peut exister sans lésion objectivable, et une lésion peut ne pas entraîner de plainte douloureuse. La souffrance psychique peut aller jusqu'à la sidération ou à des difficultés pour exprimer son état.

La **plainte** est la manière dont une personne adresse ou manifeste quelque chose de son vécu à un autre. Sa forme dépend du contexte, de l'histoire, du langage et de la relation. Écouter la plainte n'équivaut pas à supposer que sa cause est exclusivement organique ou exclusivement psychique.

> **À RETENIR**
> Ne jamais disqualifier une plainte faute de signe objectif ni annoncer à la place du patient ce qu'il ressent. Un ressenti ne peut pas être mesuré intégralement de l'extérieur.

Représentations de la maladie et théories profanes

La personne se construit des explications sur **l'origine, le sens, la durée, les conséquences, le contrôle possible et les traitements** de sa maladie. Ces représentations influencent les émotions, la recherche d'aide, l'adhésion ou le refus d'un soin et la manière de vivre avec la pathologie.

Question que se pose le patient	Ce qu'elle explore
« Pourquoi moi ? pourquoi maintenant ? »	Causes, événements de vie, responsabilité éventuelle.
« Qu'est-ce qui va m'arriver ? »	Évolution, conséquences, gravité perçue.
« Qu'est-ce que je peux faire ? »	Contrôle, ressources, choix et traitements.
« Qu'est-ce que je deviens ? »	Identité, rôles sociaux, image du corps, projets.

Les explications dites **profanes** peuvent être exogènes (origine attribuée à l'extérieur de soi) ou intégrer des causes et significations internes. Elles doivent être explorées sans être confondues avec l'étiologie médicale.

Maladie, douleur, souffrance : approfondissements essentiels

Maladie chronique, handicap et représentations

Le support distingue la description biomédicale d'une maladie (cause, symptômes, évolution, traitements) de l'expérience vécue. Une affection chronique est rarement guérissable, requiert des soins prolongés, souvent au long cours, et peut bouleverser le quotidien, les rôles et les projets. Le handicap ne peut pas être réduit au seul diagnostic : il se manifeste dans les possibilités d'autonomie, de participation et d'activité.

La représentation de la maladie se construit à partir des croyances du patient sur les causes, les conséquences, la durée, la maîtrise possible et l'intérêt du traitement. Une explication profane n'est pas un diagnostic, mais elle renseigne sur les attitudes et les comportements de soin. Le cours oppose notamment les explications **exogènes**, attribuant la maladie à un élément extérieur, à d'autres explications qui accordent un rôle à la personne ou à son histoire.

Douleur : des mécanismes et une expérience multidimensionnelle

La définition de l'IASP présentée par l'enseignante en 2020 décrit la douleur comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée, ou ressemblant à celle associée, à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Une lésion n'est donc ni obligatoire pour qu'une douleur existe, ni suffisante pour en prédire l'intensité.

Mécanisme abordé	Exemples et distinction
Nociceptif	Activation liée à une agression tissulaire : fracture, infection, inflammation
Neuropathique	Atteinte du système somatosensoriel : brûlures, décharges, picotements selon le tableau
Sans cause organique identifiée dans le support	La douleur ressentie reste réelle ; ne pas conclure à une simulation ni à une cause exclusivement psychique

Le cours envisage les effets de la douleur dans les dimensions physiques, psychologiques, sociales et spirituelles. Une douleur persistante peut modifier les activités, l'humeur, les liens et la manière de se projeter dans le temps.

Douleur chronique et souffrance psychique

La douleur chronique est, dans le support, une douleur qui persiste ou réapparaît **depuis plus de trois mois**. Elle est multifactorielle : des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux contribuent à l'expérience et au syndrome douloureux. La souffrance désigne plus largement une épreuve émotionnelle, morale ou existentielle ; elle ne se superpose pas nécessairement à la localisation d'une douleur.

La **souffrance psychique** désigne un état de mal-être qui ne correspond pas nécessairement aux critères d'une maladie psychiatrique. La **douleur morale**, évoquée dans la sémiologie psychiatrique, renvoie à une détresse particulièrement intense pouvant accompagner certaines dépressions graves. Il faut éviter de fusionner ces notions.

Expression sociale et culturelle : pourquoi l'IDE ne doit pas juger

L'expression de la douleur ou de la souffrance dépend de l'éducation, de l'environnement, des habitudes relationnelles et des références culturelles. Une personne peu expressive ne souffre pas nécessairement moins ; une personne très expressive n'exagère pas nécessairement. Le support évoque le « dolorisme » (valorisation de la souffrance) et donne un exemple historique de stéréotype culturel sur la douleur pour montrer le risque de malentendu.

Rôle infirmier : écouter, demander les mots du patient, utiliser des modalités d'évaluation adaptées, observer sans décrédibiliser, soulager dans son rôle, réévaluer et transmettre. La plainte doit être entendue comme un **appel au lien** et parfois un **appel à un acte de soulagement** ; elle n'est pas seulement une donnée gênante à faire disparaître.

Maladie, douleur, souffrance : partir du général

La maladie, avant ses formes particulières

La maladie est une altération de la santé comportant un ensemble de caractères définis : une cause, des signes et des symptômes, une évolution et des modalités thérapeutiques et pronostiques précises.

Cette définition décrit l'approche médicale. Disease désigne la maladie objectivée, illness l'expérience subjective d'être malade, et sickness sa reconnaissance et ses conséquences sociales. Une maladie chronique s'inscrit dans la durée ; elle peut transformer les activités et les projets, sans que son diagnostic suffise à décrire toute la personne.

La souffrance générale, avant la souffrance psychique

La souffrance qualifie un être qui supporte, endure ou subit une douleur physique et morale, un état de mal-être, c'est-à-dire un sentiment de non-adaptation au monde, d'étrangeté aux êtres et aux choses, d'indifférence douloureuse.

L'explication du cours précise que les dimensions physiques et morales peuvent être associées ou exister séparément. La souffrance est une perturbation globale, corporelle, psychique, émotionnelle, existentielle ou morale. Une douleur peut y contribuer, mais n'en épuise pas le sens. Une souffrance peut aussi exister sans douleur exprimée et sans trouble psychiatrique caractérisé.

Écouter ce que la personne signifie

« Je souffre » ne permet pas de conclure, à lui seul, à une douleur localisée ou à une souffrance psychique. Il faut explorer le vécu, le sens donné à l'épreuve et ses conséquences. La douleur comporte elle aussi des dimensions émotionnelles et cognitives : la distinction ne doit pas devenir une opposition entre un corps réel et un psychisme imaginaire.

Consigne de restitution annoncée

Pour la douleur chronique, définir d'abord la douleur en général, puis la persistance ou la réapparition au-delà de trois mois et la dimension multifactorielle. Pour la souffrance psychique, donner d'abord la définition générale de la souffrance. Appliquer ensuite ces notions aux éléments du témoignage, au lieu d'aligner des mots-clés.

Comprendre et accompagner l'expérience douloureuse

Le modèle multidimensionnel du cours emploie les libellés « nociceptif », « neuropathique » et « psychogène ». Ces mécanismes présentés ne se confondent pas avec les composantes de l'expérience : sensori-discriminative, affective et émotionnelle, cognitive et comportementale. Les manifestations observables peuvent être motrices, verbales ou neurophysiologiques. Leur absence ne suffit pas à invalider le vécu douloureux. Le libellé « psychogène » appartient au modèle exposé : une cause non identifiée ne démontre à elle seule ni une origine exclusivement psychique ni une simulation.

Attention, interprétation et distraction

L'attention portée à une douleur, l'angoisse et la signification attribuée à la sensation peuvent en modifier le vécu. Une activité choisie avec la personne peut déplacer une partie de son attention et participer à son ajustement. La distraction ne nie pas la douleur et ne remplace pas sa prise en charge. L'infirmier écoute les préférences et la fatigue, propose une activité adaptée et réévalue avec la personne l'effet ressenti.

Croyance explorée par le PBPI	Question à comprendre
Mystère	La personne ne comprend pas l'origine de sa douleur : « On ne sait pas ce que j'ai. »
Pérennité	Elle pense que la douleur persistera dans l'avenir : « Cela ne finira jamais. »
Constance	Elle estime que la douleur est continuellement présente : « Je n'ai aucun répit. »
Culpabilité	Elle s'attribue la responsabilité de sa douleur ou de son maintien : « C'est ma faute. »

Ces exemples servent à distinguer les croyances, sans constituer des paroles effectivement recueillies ni un diagnostic. Les explorer aide à comprendre l'appréhension du soin, le recours à l'aide et les ressources possibles.

> **Aiguë et chronique : des finalités qui diffèrent**
>
> La douleur aiguë a notamment une fonction de signal et appelle une recherche de cause et une prise en charge adaptée. Dans la douleur chronique, le maintien de la douleur et ses effets deviennent complexes et multifactoriels : la réadaptation, les activités et la participation de la personne prennent une place importante. Les facteurs personnels et contextuels sont des facteurs de risque ou de maintien possibles, pas une preuve que la personne est responsable de sa douleur.

EXEMPLE D'ANALYSE

Une personne refuse un traitement parce qu'elle l'associe à un événement traumatisant vécu par un proche. On repère d'abord sa **représentation de la maladie et du soin**, puis on examine son besoin de contrôle ; on n'étiquette pas immédiatement ce refus comme « mauvaise volonté ».

03 · Modèle intégratif et déterminants de la santé

Prédicteurs, modérateurs et issues

Le modèle intégratif présenté en cours articule trois niveaux. Il évite une lecture monocausale de la maladie : aucun facteur biologique, psychologique ou social ne suffit à lui seul à expliquer toutes les trajectoires.

Étape	Rôle	Exemples
Prédicteurs	Facteurs personnels et socio-environnementaux pouvant influer sur risque/pronostic.	Antécédents, conditions de vie, comportements, personnalité.
Modérateurs / processus transactionnels	Manière dont la personne évalue la situation et mobilise ses ressources.	Stress perçu, contrôle perçu, soutien perçu, coping.
Issues / critères d'ajustement	Conséquences sur les dimensions somatiques et psychosociales.	Évolution de l'état de santé, ajustement émotionnel ou comportemental.

Les facteurs de risque, de protection et les événements stressants

Les facteurs personnels comprennent certaines caractéristiques psychologiques, les ressources et les vulnérabilités de la personne. Les facteurs environnementaux concernent le milieu physique, économique, social, culturel et familial. Un **déclencheur** ou **stresseur** survient dans un contexte donné ; le facteur de risque accroît une probabilité, sans constituer un destin individuel.

Les ressources protectrices peuvent amortir un risque : réseau social fiable, capacités d'adaptation, accès à des aides et présence de figures soutenantes. Les facteurs salutogènes désignent des éléments qui favorisent la préservation de la santé et les capacités d'ajustement.

POUR COMPRENDRE

Une même contrainte peut être vécue différemment selon les antécédents, la perception de menace et les ressources mobilisables. Ne pas transformer un facteur statistique en diagnostic individuel.

04 · Soutien social : reçu, perçu et mobilisé

Le soutien social est un concept central. Dans son sens général, il inclut les aides **données et reçues** au sein de l'entourage familial, amical, de voisinage ou institutionnel. Le réseau social n'est pas identique au sentiment d'être réellement soutenu.

Modèles de santé et événements de vie

Pourquoi le modèle intégratif ne se résume-t-il pas au biomédical ?

Le modèle biomédical recherche des atteintes organiques et leurs mécanismes ; il est indispensable, mais explique mal à lui seul les différences de vécu, d'adhésion ou de trajectoire. Les modèles linéaires relient des antécédents à des effets, alors que le modèle biopsychosocial ouvre les dimensions étudiées, sans forcément préciser comment elles interagissent. Le modèle intégratif et multifactoriel, présenté dans le cours à partir de Bruchon-Schweitzer et Dantzer, s'intéresse précisément à ces interactions.

Niveau	Fonction dans le modèle intégratif
Prédicteurs	Antécédents personnels, biologiques et socio-environnementaux ; facteurs de risque/protection, événements de vie
Processus modérateurs	Évaluation cognitive, stress perçu, contrôle et soutien perçus, coping et réactions physiologiques
Issues	Conséquences somatiques, comportementales, émotionnelles et cognitives de l'ajustement

Exemple : deux patients reçoivent le même diagnostic. Leurs antécédents et contraintes diffèrent ; ils n'évaluent pas la menace de la même manière, n'ont pas le même soutien et ne mobilisent pas les mêmes stratégies. L'ajustement et la qualité de vie peuvent donc être différents, sans que l'un soit « responsable » de sa maladie.

Déterminants et inégalités sociales de santé

Les déterminants présentés couvrent notamment les facteurs biologiques, les environnements de vie et de travail, les ressources socio-économiques, les comportements, les normes culturelles et les conditions d'accès au système de soins. Le support souligne que l'amélioration globale de l'espérance de vie n'efface pas les écarts entre groupes sociaux : les expositions professionnelles, les conditions matérielles et les possibilités de prévention contribuent à ces inégalités. Une différence statistique entre groupes ne permet pas d'expliquer automatiquement le cas d'un patient particulier.

Les événements de vie : distinguer événement et réaction

Un événement de vie est un changement relativement rapide, suffisamment important pour créer une discontinuité dans la vie de la personne. Le cours distingue aussi les **difficultés de vie** (situations problématiques d'au moins quatre semaines), les **tracas** ou incidents mineurs, et les événements complexes ou répétés pouvant ressembler à des stresseurs chroniques. Perte, agression, épuisement, attente et bouleversement des habitudes sont des catégories explicatives présentées dans le support.

L'échelle de Holmes et Rahe : un repère historique à nuancer

La Social Readjustment Rating Scale (1967) propose 43 événements de vie pondérés pour estimer les changements d'adaptation demandés. Le support cite le seuil historique d'un score supérieur à 300 comme associé à un risque de maladie plus élevé. **Ce chiffre n'est pas un diagnostic individuel, ni une relation causale automatique.** Deux personnes peuvent réagir très différemment au même événement selon leur vécu, leur âge, leur contexte et leur soutien.

En pratique : explorer l'impact subjectif du changement, sa durée, ses répétitions et les ressources accessibles. Le modèle transactionnel approfondit justement la manière dont la personne évalue la situation, plutôt que de s'arrêter au nombre d'événements.

Modèles intégratifs et événements : raisonner en contexte

Le modèle intégratif distingue les antécédents ou prédicteurs, les processus qui modulent la relation entre eux et les issues de santé. Les facteurs biologiques et personnels, les événements et l'environnement sont appréhendés à travers les évaluations de la personne, son contrôle et son soutien perçus, puis ses stratégies d'ajustement. Les issues peuvent être somatiques et subjectives, notamment la qualité de vie. Ces dimensions sont en interaction.

Un facteur associé à un risque dans une population n'explique pas à lui seul la trajectoire d'un individu. Les conditions de logement et de travail, les comportements, l'accès aux soins, les connaissances de santé et le contexte socioculturel participent aux possibilités réelles de prévention et de soin. Une lecture uniquement individuelle ferait perdre ces déterminants.

Identifier une discontinuité datable

Situation	Qualification à justifier
Annonce d'un diagnostic ou aggravation annoncée	Événement extérieur relativement rapide et important, dont on peut situer le moment. Son retentissement dépend du vécu et du contexte.
Vivre avec une maladie depuis dix ans	Situation durable ; ne pas la présenter entièrement comme un événement ponctuel. Rechercher l'annonce, un changement ou une aggravation identifiables.
Situation problématique persistante	Difficulté de vie lorsqu'elle dure au moins quatre semaines selon le repère du cours.
Petites contrariétés répétées	Tracas quotidiens dont l'accumulation peut peser sur l'adaptation.

Un événement heureux peut lui aussi demander une adaptation et être stressant. Les événements peuvent concerner une perte, une agression, l'épuisement, une attente ou un changement d'habitudes. Un événement complexe associe plusieurs dimensions d'une même épreuve ; des événements en série se succèdent et peuvent cumuler leurs effets.

> **Consigne annoncée pour l'analyse**
>
> Préciser ce qui s'est passé et quand, puis montrer l'importance de ce changement pour cette personne. L'échelle historique de Holmes et Rahe recense 43 événements ; un score supérieur à 300 est un repère de risque dans ce modèle, pas un diagnostic ni une prédiction certaine.

Notion	Sens / repère clinique
Réseau social	Ensemble des personnes avec lesquelles l'individu est en relation.
Soutien social reçu	Aides et relations effectivement disponibles ou apportées.
Soutien social perçu	Appréciation subjective de la disponibilité, de la qualité et de l'adéquation du soutien.
Soutien social mobilisé	Démarches et demandes d'aide réalisées pour faire face à une situation.

Les dimensions pratiques et relationnelles

Le cours évoque notamment des soutiens matériels/instrumentaux, émotionnels/affectifs, informatifs, d'estime et d'intégration/appartenance. Les formes concrètes vont de l'aide au logement aux informations pour prendre une décision, en passant par l'écoute et la reconnaissance.

Le soutien perçu peut protéger face aux difficultés : le sentiment de pouvoir compter sur quelqu'un est parfois plus décisif que la seule taille du réseau social. L'isolement peut au contraire constituer un facteur de vulnérabilité.

APPLICATION AU SOIN

Explorer séparément « Qui est présent ? », « Qui peut vraiment vous aider ? » et « Vous sentez-vous soutenu ? ». La quantité de contacts ne renseigne pas à elle seule sur leur qualité.

05 · Vulnérabilité, personnalité et résilience

La vulnérabilité : deux axes

La vulnérabilité correspond à une moindre résistance à certaines agressions ou contraintes, avec des fragilités potentielles, visibles ou latentes. Elle peut relever de facteurs personnels (histoire, caractéristiques biologiques ou psychologiques, développement, ressources) et de facteurs liés à l'environnement (milieu relationnel, sécurité, contexte socio-économique, expériences de vie).

Axe	Éléments cités dans le cours
Personnelle	Caractéristiques individuelles, prédispositions, développement, capacités de régulation.
Environnementale	Carences du milieu, interactions relationnelles inadéquates, contexte social/familial.

La résilience : une pluralité de définitions

Le concept provient notamment de la physique des matériaux puis est repris en psychologie. Il désigne un **processus d'adaptation, de récupération et de réorganisation** après une épreuve ; il ne signifie pas l'absence de douleur ni une invulnérabilité de la personne.

Soutien social : évaluer l'aide et son adéquation

Le soutien social comprend l'aide donnée et reçue dans les relations. Un réseau décrit les ressources relationnelles potentielles ; le soutien reçu décrit des actions effectivement apportées ; le soutien perçu correspond à l'évaluation, par la personne, de leur disponibilité et de sa satisfaction. Beaucoup de relations ne garantissent donc pas le sentiment d'être soutenu.

Dimension	Exemple d'aide à adapter au besoin
Émotionnelle	Écoute, présence et possibilité de parler sans imposer l'expression.
Intégration sociale	Appartenance à un groupe et maintien de liens ou d'activités partagées.
Estime	Reconnaissance des capacités et encouragements sans jugement ni culpabilisation.
Informative	Informations compréhensibles et crédibles pour se repérer et décider.
Matérielle ou instrumentale	Aide concrète, transport, tâches ou démarches effectivement organisées.

Des mesures différentes

Le SNS renseigne le réseau potentiel, sans prouver que l'aide correspond au besoin. Le soutien reçu, exploré notamment par l'ISSB, repose sur le récit d'actions antérieures et peut être soumis aux biais de rappel. Le SSQ et le QSSP explorent le soutien perçu, en distinguant disponibilité et satisfaction ; les personnes et les types d'aide concernés comptent également.

L'effet direct désigne les effets associés aux relations et aux ressources sociales indépendamment d'un épisode de stress. L'effet tampon désigne leur intervention dans la relation entre stress et santé : modification de l'évaluation, de la réponse émotionnelle et de la réactivité. Ces modèles ne promettent pas une guérison automatique. Les soins de support associent plusieurs professionnels et complètent les traitements, avec un objectif de qualité de vie.

Application infirmière

Demander : « Sur qui pouvez-vous compter ? Cette aide vous convient-elle ? » Puis préciser une aide concrète et un relais adapté. Le professionnel peut offrir un soutien émotionnel autant qu'informatif. Une aide excessive, inadéquate ou imposée peut être mal vécue ; une promesse vague ne remplace pas un accompagnement organisé.

Consigne annoncée

Pour identifier un soutien social perçu dans un témoignage, citer une appréciation de la personne sur l'aide disponible ou sa satisfaction. La seule présence d'amis ou de famille ne suffit pas à justifier le caractère « perçu ».

Soutien social et personnalité : ce que le support ajoute

Soutien social : cinq dimensions et adéquation au besoin

Le soutien peut être émotionnel, d'estime, d'information, matériel ou d'intégration/appartenance. Le cours distingue réseau social, soutien effectivement reçu et soutien perçu. Son efficacité dépend de l'adéquation entre l'aide proposée et les besoins de la personne : une aide excessive, imposée ou inadaptée peut être mal vécue malgré une intention favorable.

Les soins de support en cancérologie illustrent cette approche : soutenir la qualité de vie peut requérir des aides psychologiques, sociales, nutritionnelles et relationnelles en complément des traitements. Pour un IDE, la question n'est pas seulement « Qui est là ? » mais aussi « Cette aide vous convient-elle ? ».

Profils A, B, C : repères historiques, non étiquettes médicales

Profil évoqué	Description et réserve à connaître
Type A	Impatience, compétitivité, irritabilité, hostilité, recherche de maîtrise ; la littérature historique évoque un lien avec le risque coronarien, mais le cours souligne que les études ultérieures ont nuancé ce lien
Type B	Description contrastée : moindre compétitivité, moins d'agressivité et davantage de tolérance ; ne pas en faire une protection individuelle garantie
Type C	Inhibition de certaines émotions négatives, difficulté à s'affirmer, attitude conciliante ; les hypothèses anciennes de lien avec le cancer ne démontrent pas qu'une personnalité « provoque » ce cancer

Des traits comme l'hostilité, le névrosisme et l'anxiété sont discutés comme facteurs de vulnérabilité possibles. Un trait ne définit ni la valeur d'une personne, ni un diagnostic, ni une causalité inéluctable de maladie. Le cours encourage de plus en plus à étudier les processus et comportements en situation plutôt qu'à enfermer les personnes dans des types fixes.

Ressources salutogènes : optimisme, lieu de contrôle et auto-efficacité

Optimisme : tendance générale à anticiper une issue favorable aux événements ; le support cite le questionnaire LOT-R. Il peut soutenir l'ajustement, sans assurer une bonne santé dans tous les cas.

Lieu de contrôle (locus of control) : croyance générale selon laquelle les événements dépendent plutôt de ses actions et capacités (interne) ou de circonstances extérieures comme le hasard ou des personnes influentes (externe). Cela ne signifie pas que le patient maîtrise réellement toutes les causes de son état.

Auto-efficacité : croyance qu'une personne est capable, grâce à ses ressources, de mener les actions nécessaires pour réussir une tâche ou faire face à une situation. Le support évoque l'échelle de Jerusalem et Schwarzer (1992), ainsi que des liens possibles avec l'adhésion thérapeutique et le bien-être.

Appliquer ces notions en situation de soin

Si une personne dit « je ne vais pas y arriver » malgré un entourage présent, distinguer confiance dans sa capacité d'action (auto-efficacité), perception de l'aide disponible (soutien perçu) et croyance sur ce qu'elle peut influencer (contrôle perçu). Le soignant peut proposer des objectifs réalisables, vérifier les obstacles concrets et renforcer les ressources, sans nier la difficulté ni culpabiliser le patient.

DÉFINITIONS COMPLÈTES ESSENTIELLES

Le cours présente plusieurs formulations complémentaires : celle de **Rutter** sur la capacité à mener une vie normale après des événements très adverses et à développer des stratégies d'ajustement protectrices ; celle de **Boris Cyrulnik** sur le développement malgré un environnement délabrant ; et une définition psychologique générale comme processus permettant de continuer à se construire après une épreuve traumatique. Leurs formulations entières sont reproduites dans « Définitions et mots-clés ».

Les observations longitudinales d'Emmy Werner servent de repère historique pour montrer que certains enfants exposés à des facteurs de risque développent, à l'âge adulte, des capacités d'adaptation satisfaisantes. Le cours souligne l'interaction entre ressources internes et facteurs protecteurs environnementaux.

Personnalité et vulnérabilité

La personnalité est présentée comme un ensemble relativement stable de manières de percevoir, ressentir, penser et agir. Le cours examine certains traits potentiellement associés à la vulnérabilité et au stress, sans permettre de conclure qu'un trait isolé cause une maladie.

L'hostilité est étudiée à travers plusieurs composantes : **cynisme**, **attributions hostiles**, **affects hostiles**, **réponses agressives** et **évitement social**. Il faut distinguer attitudes, émotions et comportements. Des dimensions telles que pessimisme, anxiété ou méfiance peuvent modifier l'évaluation de situations, sans constituer des jugements moraux sur le patient.

À RETENIR

La résilience n'est ni une qualité « héroïque » garantie, ni le contraire automatique de toute vulnérabilité. Elle dépend de l'histoire de la personne, des conditions de l'épreuve et des ressources qui deviennent accessibles.

06 · Stress, évaluation cognitive et contrôle perçu

Le modèle transactionnel du stress

Selon l'approche transactionnelle présentée, le stress traduit une **relation entre la personne et son environnement** évaluée comme menaçante, éprouvante ou dépassant ses ressources. Deux évaluations cognitives sont mises en avant : l'évaluation primaire de la situation (menace, perte, défi) et l'évaluation secondaire des ressources et possibilités d'action.

Phase	Question de la personne	Conséquence sur la réaction
Évaluation primaire	« Que signifie cette situation pour moi ? »	Perception d'une menace, d'une perte ou d'un défi.
Évaluation secondaire	« Ai-je les moyens d'y faire face ? »	Appréciation de ses ressources propres et sociales.
Ajustement	« Quelles actions puis-je entreprendre ? »	Mise en œuvre de coping, recherche de soutien, réévaluation.

La double évaluation explique pourquoi le même diagnostic ou le même événement ne produit pas la même intensité de stress chez toutes les personnes. Le **stress perçu** dépend de cette interprétation subjective.

Vulnérabilité et résilience : des trajectoires ouvertes

La vulnérabilité se comprend au croisement de facteurs personnels et environnementaux, innés ou acquis. Leur constellation et leur cumul comptent, de même que les ressources disponibles. Une séparation, une difficulté familiale ou un trait individuel ne déterminent pas mécaniquement un trouble.

La résilience suppose une adversité importante et un processus dans le temps ; elle ne signifie ni invulnérabilité, ni absence de souffrance, ni obligation de tirer un bénéfice de chaque épreuve. Le cours retient notamment la définition complète de Rutter : capacité pour des individus ayant subi des événements de vie très aversifs, ou même dramatiques, d'arriver à mener une vie normale ; les sujets résilients sont capables de développer, dans des circonstances parfois très difficiles, des stratégies d'ajustement adéquates qui les protègent.

Processus d'accompagnement	Ce que le soignant peut soutenir
Accueil	Reconnaître l'épreuve et la souffrance avec bienveillance. La reconnaissance de ce qui a été subi précède une éventuelle reconstruction ; ne pas demander de « passer à autre chose ».
Expression	Permettre une parole et des émotions au rythme de la personne, sans les forcer. Respecter les protections et reconnaître aussi les limites de ce que le soignant peut accueillir.
Reconstruction	Soutenir l'estime, les capacités d'agir, les liens et les investissements possibles. De petites réussites peuvent nourrir la confiance puis un nouvel engagement.

Ces trois processus ne constituent pas un calendrier obligatoire. Les ressources peuvent être internes, familiales et sociales : résolution de problèmes, expériences de réussite, liens sécurisants, environnement accueillant. Demander de l'aide peut être une ressource ; un lien de sécurité peut garder sa valeur même sans présence physique constante. Un tuteur de résilience est une possibilité, pas une condition unique.

Présence et relais

Une personne évoque sa peur de mourir. Écouter ce qu'elle veut dire et reconnaître l'incertitude permet de maintenir le lien ; une réassurance mensongère peut fermer l'expression. Si le soignant est dépassé, chercher un relais effectif en accompagnant la personne, sans la laisser seule avec une promesse abstraite.

Priorité de définition annoncée

Connaître la définition générale et la formulation de Rutter jusqu'au bout. Celle de Cyrulnik complète cette compréhension ; une simple formule sur le fait de « rebondir » serait insuffisante.

Personnalité, ressources et santé : distinguer les hypothèses

Les types A, B et C sont des modèles historiques de profils et de comportements. Le type A associe notamment impatience, compétition et parfois hostilité ; le type B est décrit par opposition comme plus calme. Le type C concerne l'inhibition des émotions négatives et la conciliation, sans se réduire à la gentillesse. Les résultats sur les liens du type C avec le cancer sont contradictoires : ces profils ne permettent pas de prédire une maladie individuelle.

Hypothèse autour de l'hostilité	Mécanisme proposé dans le cours
Physiologique	Une réactivité accrue face au stress, notamment sympathique et corticosurrénalienne, pourrait contribuer aux relations observées avec la santé.
Psychosociale	Les conflits, un soutien social moindre et certains comportements à risque pourraient intervenir dans ces relations.

Ces mécanismes sont présentés comme des hypothèses. Ils n'autorisent ni causalité certaine, ni jugement moral, ni diagnostic à partir d'une attitude. Le névrosisme et l'anxiété constituent également des dispositions étudiées ; un trait ne suffit pas à caractériser un trouble. Les anciens risques chiffrés cités dans les études ne sont pas des prédictions actuelles pour un patient.

Des ressources à distinguer

L'optimisme est un style d'attente favorable, mesuré notamment par le LOT-R. Les mécanismes proposés concernent des ajustements au problème, la persistance et les comportements de santé ; il ne s'agit pas d'une obligation d'être positif. L'auto-efficacité concerne la croyance de pouvoir mobiliser ses ressources pour une tâche ou une situation.

Le lieu de contrôle est une croyance générale : les événements dépendent-ils plutôt de ses actions, du hasard ou d'autrui ? Le contrôle perçu correspond à l'évaluation d'une situation donnée. Aucun des deux ne garantit la maîtrise objective de l'événement. Une personne peut reconnaître une limite réelle tout en cherchant une action possible.

> **Émotion et stratégie ne se confondent pas**
>
> Ressentir colère, peur ou tristesse n'est pas en soi une stratégie de coping centrée sur l'émotion. Ce coping désigne les efforts de gestion de l'impact émotionnel ; il ne signifie pas une simple présence d'émotions négatives.

Le contrôle perçu

Le contrôle perçu décrit la croyance qu'une personne peut agir sur la situation, ses conséquences ou sa propre réaction. Le cours évoque des dimensions de contrôle interne, lié aux autres (« personnages puissants ») et au hasard/chance. Un sentiment de contrôle peut atténuer l'angoisse, mais tout n'est pas contrôlable par la personne malade.

SITUATION INFIRMIÈRE

La personne demande systématiquement des informations sur ses soins : cela peut traduire une tentative de **reprendre du contrôle**, et non seulement de la méfiance. Expliquer les étapes, accueillir les questions et distinguer choix possibles et contraintes réelles.

07 · Stratégies d'ajustement : coping

Le coping désigne les efforts cognitifs et comportementaux déployés face à une situation évaluée comme exigeante ou stressante. Il s'agit de stratégies en lien avec une situation et susceptibles de changer, par opposition aux mécanismes de défense présentés comme largement inconscients.

Type de coping	Objectif	Exemples du cours
Centré sur le problème	Réduire les exigences de la situation ou augmenter les ressources.	Rechercher des informations, élaborer un plan, agir sur la difficulté.
Centré sur l'émotion	Gérer les émotions suscitées par la situation.	Réévaluation positive, mise à distance, expression émotionnelle, diversion.
Centré sur la recherche de soutien	Obtenir écoute, réassurance, informations, aide matérielle.	Solliciter un proche, demander conseil, chercher une aide concrète.

Le cours distingue, pour le coping centré sur le problème, **résolution du problème** et **affrontement de la situation**. Pour le coping centré sur l'émotion, il présente notamment **fuite/évitement**, **minimisation avec distance**, **réévaluation positive**, **auto-accusation** et **recherche de soutien émotionnel**.

ATTENTION AU CONTEXTE

Une stratégie n'est pas bonne ou mauvaise isolément : elle dépend du contexte, du moment et de ses conséquences. La réévaluation positive n'efface pas un risque réel et la recherche de soutien n'est pas synonyme de faiblesse.

08 · Angoisse et mécanismes de défense face à la maladie

Angoisse et fonctions protectrices des défenses

L'angoisse est présentée comme une peur sans objet extérieur défini, exprimant une souffrance psychique face à une menace intérieure. Elle peut servir de signal d'alarme et déclencher des mécanismes de défense. Il s'agit ici du modèle théorique psychanalytique, non d'une structure anatomique.

Les mécanismes de défense sont des réponses **largement inconscientes** par lesquelles le psychisme cherche à se protéger d'une réalité, d'un conflit ou d'une angoisse trop difficile à supporter. Ils peuvent gagner du temps pour intégrer un événement ; ils deviennent problématiques selon leur rigidité, leur intensité, leur fréquence et leurs conséquences.

Stress : articuler la réponse biologique et la transaction

Dans le modèle biologique de Selye, présenté en 1936, le stress est une réponse générale de l'organisme à une sollicitation ; l'agent qui la provoque est le stresseur. Cette réponse mobilise des ressources d'adaptation. Le stress n'est donc pas nécessairement pathologique.

Syndrome général d'adaptation	Ce qui est décrit
Alarme	Mobilisation initiale face à la sollicitation, avec activation sympathique et intervention de l'adrénaline et de la noradrénaline.
Résistance	Maintien de l'adaptation lorsque la sollicitation se prolonge, avec une place importante du cortisol dans la réponse.
Épuisement	Lorsque les capacités d'adaptation sont dépassées, les fonctions se dérèglent. Le modèle ne permet pas de dater automatiquement ces phases chez une personne.

Ce modèle décrit une réponse physiologique. L'approche transactionnelle de Lazarus et Folkman ajoute la relation dynamique entre la personne et son environnement : le stress dépend de l'évaluation des exigences et des ressources, et des ajustements qui se construisent. Une même situation n'est pas vécue de manière identique par tous.

Évaluation	Question de la personne
Primaire	Que représente cette situation pour moi : perte, menace, défi ou enjeu ?
Secondaire	De quelles ressources, possibilités de contrôle et aides puis-je disposer pour y faire face ?

Repérer le stress perçu

Une annonce peut être potentiellement stressante. Pour parler de stress perçu dans un témoignage, rechercher une évaluation telle que « Je n'y arriverai pas » ou « Je me sens dépassé ». Nommer uniquement le diagnostic ou le geste annoncé ne démontre pas la manière dont la personne l'évalue.

Des niveaux d'analyse complémentaires

La réponse biologique, l'évaluation cognitive et les stratégies d'ajustement s'éclairent mutuellement. Une liste de maladies associées au stress dans le support ne prouve pas que le stress cause chaque maladie, ni que le patient en est responsable.

Coping : identifier un effort d'ajustement

Le coping regroupe les efforts cognitifs et comportementaux par lesquels la personne cherche à gérer les exigences qu'elle évalue comme dépassant ses ressources, en maîtrisant la situation et/ou en diminuant son impact sur le bien-être. Il concerne des démarches conscientes et contextuelles, susceptibles de changer et de s'apprendre. Plusieurs stratégies peuvent se succéder dans une même situation.

Forme	Ce que cherche la stratégie
Centrée sur le problème	Modifier la situation : rechercher des informations, résoudre une difficulté, agir ou affronter le problème.
Centrée sur l'émotion	Réguler l'impact émotionnel de la situation. La réaction émotionnelle seule ne suffit pas à la qualifier.
Recherche de soutien social	Mobiliser une écoute, une information ou une aide matérielle auprès d'autrui.

Distinguer les cinq sous-dimensions émotionnelles

Sous-dimension	Exemple de démarche
Fuite-évitement	Se détourner de la situation ou des pensées qui lui sont associées.
Minimisation de la menace avec prise de distance	Réduire l'importance attribuée à la difficulté et prendre du recul.
Réévaluation positive	Trouver une signification ou un bénéfice nouveau dans l'épreuve ; ce n'est pas simplement la déclarer peu importante.
Auto-accusation	S'attribuer des reproches ou la responsabilité de la situation.
Recherche de soutien émotionnel	Chercher auprès d'autrui une écoute ou une compréhension pour réguler les émotions.

L'efficacité dépend du contexte et de la contrôlabilité réelle ou perçue. Une action sur le problème peut être pertinente lorsqu'une solution est possible ; une régulation émotionnelle peut aider quand certains aspects s'imposent. Il n'existe pas une stratégie bonne dans toute situation.

La distraction, par exemple écouter de la musique, illustre aussi une façon de détourner l'attention dans le coping émotionnel. Elle ne remplace pas l'une des cinq sous-dimensions explicitement retenues dans le cours.

Consigne annoncée pour la copie

Définir le coping général, puis sa forme et, si elle est justifiée, la sous-dimension. Citer ensuite les éléments du témoignage qui montrent l'effort d'ajustement. « Elle est en colère » décrit une émotion ; il faut préciser ce qu'elle fait ou pense pour y faire face.

Défenses : comprendre sans étiqueter la personne

Les topiques psychanalytiques sont des modèles théoriques du fonctionnement psychique, et non des structures anatomiques du cerveau. La première topique distingue conscient, préconscient et inconscient ; la seconde distingue Ça, Moi et Surmoi. Dans ce cadre, le Moi mobilise des défenses pour se protéger de l'angoisse.

L'angoisse peut être décrite comme une expérience difficile à nommer ou à représenter. La maladie, la dépendance, les atteintes à l'intégrité et la peur de perdre un proche peuvent la mobiliser. Les mécanismes de défense sont principalement inconscients ; ils se distinguent des efforts de coping conscients et contextuels.

Distinction	Ce que l'on cherche à comprendre
Déni / refus informé	Le déni écarte inconsciemment une réalité insupportable. Un désaccord ou un refus éclairé ne prouvent pas un déni.
Projection / déplacement	La projection attribue à autrui des contenus propres ; le déplacement déplace l'affect vers un autre objet. Ne pas les déduire d'une seule parole agressive.
Isolation / isolement social	L'isolation sépare une représentation de son affect ; elle ne signifie pas être sans entourage.
Refoulement / dénégation	Le refoulement maintient hors de la conscience ; la dénégation laisse apparaître un contenu tout en le niant. Le lexique précise leurs définitions.
Régression / maîtrise	Accepter temporairement d'être aidé peut protéger ; une dépendance durable peut limiter l'autonomie. Vérifier et contrôler les soins peut aussi chercher à réduire l'incertitude.

La rationalisation donne une explication logique qui peut masquer un motif inconscient. L'activisme peut prendre la forme d'une activité frénétique, sans démontrer à lui seul un choix délibéré. L'affiliation mobilise le lien avec autrui. Le retrait peut protéger momentanément tout en augmentant le risque de solitude. Les deux sens de la sublimation sont conservés dans le lexique.

> **Une posture de soin**
>
> Apprécier l'intensité, la fréquence, la rigidité et les conséquences pour la personne. Respecter une protection qui ne met pas en danger, sans la confronter brutalement. L'humour comme défense est auto-appliqué : cette notion n'autorise pas le soignant à se moquer du patient. Ces repères n'établissent pas un diagnostic de structure psychique.

PRIORITÉ RELATIONNELLE

Face à une maladie grave, le déni et d'autres défenses peuvent être **protecteurs au début**. Il faut les identifier et généralement les respecter lorsqu'ils ne compromettent pas la santé ou la vie, plutôt que chercher systématiquement à les « casser ».

Les 14 mécanismes explicitement répertoriés

Famille d'observation	Mécanismes à connaître
Rapport à la réalité et aux représentations	Déni ; projection et projection agressive ; refoulement ; isolation ; dénégation.
Réactions d'adaptation et de conduite	Régression ; rationalisation ; déplacement ; maîtrise ; retrait apathique ; activisme et combativité.
Mécanismes pouvant soutenir l'ajustement	Affiliation ; humour ; sublimation.

Ces regroupements servent à réviser et ne constituent pas une classification formelle de l'enseignante. Les définitions intégrales sont regroupées à la fin. **Attention : l'affiliation ici est un mécanisme de défense ; ce n'est pas la notion distincte développée en psychologie sociale.**

Ce qu'observe le soignant

La projection peut se manifester par des reproches dirigés vers les soignants ; la régression, par un besoin accru de dépendance et d'attention ; la maîtrise, par la recherche insistante d'informations. Ces manifestations ne doivent pas être interprétées hors contexte ni étiquetées sans écoute. Les professionnels ont eux aussi des réactions défensives face à la souffrance et aux limites du soin.

EXEMPLE

Après l'annonce d'une maladie, une personne semble impassible et parle des détails matériels. Il peut s'agir d'une manière de se protéger momentanément. Décrire le comportement observé avant d'en proposer l'interprétation.

09 · Annonce du diagnostic et réactions psychiques

L'annonce du diagnostic est abordée comme un acte médical qui peut provoquer un choc psychologique, un bouleversement et une épreuve pour le patient et les proches. Sa signification excède la transmission d'une information biomédicale : elle peut modifier l'identité, susciter une quête de sens et mettre en mouvement un travail de deuil.

Le cours met en parallèle les **stratégies de coping** (plutôt liées à la situation et aux efforts d'ajustement) et les **mécanismes de défense** (en partie structuraux et inconscients). Les réactions ne sont ni uniformes ni nécessairement linéaires.

Les étapes de Kübler-Ross : un repère, pas une obligation

Le support de cours présente une succession descriptive de réactions possibles face à l'annonce :

Étape présentée	Manifestations possibles dans le cours
1 · Sidération / choc	Difficulté momentanée à réaliser, réfléchir ou analyser l'information ; absence de réaction ou de parole.
2 · Déni	Refus de reconnaître la réalité annoncée ; mise en doute de l'information.
3 · Colère / révolte	Sentiment d'injustice, agressivité, culpabilité, révolte.
4 · Marchandage / négociation	Tentatives de négocier modalités et calendrier de prise en charge.
5 · Dépression	Prise de conscience de l'annonce, de la maladie et de ses conséquences.
6 · Acceptation	Prise en compte progressive des contraintes de la maladie, des soins ou des séquelles.

Ces étapes ne constituent pas un calendrier obligatoire ni une méthode pour ranger mécaniquement un patient dans une catégorie. Le cours invite surtout à repérer les réactions réelles et à accueillir leur singularité.

DÉFINITION CENTRALE DE L'ANNONCE

La formulation complète qui précise le **choc psychologique, l'épreuve, le bouleversement et le traumatisme** est reproduite dans le lexique final. Une définition limitée à « dire la maladie au patient » serait incomplète.

Posture relationnelle

- Accueillir une réaction sans l'interpréter d'emblée comme pathologique ; distinguer ce qui est dit, ce qui est observé et ce qui est supposé.
- Reconnaître l'impact sur les proches sans retirer au patient sa place de sujet.
- Respecter un mécanisme protecteur lorsqu'il n'expose pas le patient à un danger et rester attentif aux conséquences sur l'accès aux soins.
- Reformuler, soutenir et transmettre les éléments cliniques pertinents dans le respect des rôles professionnels.

10 · Le corps en psychologie : schéma, image et identité

Le cours distingue le **corps-objet** de la médecine, étudié biologiquement et souvent par organes, et le **corps-sujet** en psychologie : corps vécu, singulier, indissociable de l'histoire, du psychisme, du langage et des relations.

Lorsque la personne est en bonne santé, le corps peut rester au second plan de la conscience. La maladie, la douleur et les transformations corporelles peuvent le rendre central, imposer de nouveaux apprentissages et modifier l'identité vécue.

Notion	Point central
Schéma corporel	Organisation des repères sensorimoteurs et posturaux qui permettent de percevoir et d'utiliser son corps dans l'espace.
Image du corps	Représentation subjective et affective que la personne se construit de son corps et de son apparence.

Annonce : comprendre le bouleversement et ses variations

L'annonce du diagnostic est l'acte médical par lequel un médecin fait part à un patient du diagnostic d'une pathologie aiguë, chronique ou d'un handicap. La définition du support inclut le choc psychologique, l'épreuve, le bouleversement et le traumatisme pour le patient et ses proches, au sens d'une effraction dans le psychisme. La réduire à une transmission de faits serait incomplète.

L'explication du cours nuance la portée du mot « toujours » employé dans la définition : l'impact dépend de l'annonce, de la personne, de ses expériences et de son contexte. Une annonce peut être traumatisante ; cela ne signifie pas qu'un trouble psychotraumatique est automatiquement présent chez tous.

Sens, identité et protections

Nommer la maladie peut modifier la manière dont la personne se perçoit, ses projets, son rapport au corps et la place de ses proches. Elle cherche une signification, mobilise des représentations de la maladie, des défenses et des stratégies d'ajustement. Dans l'explication psychanalytique, l'effraction et le pare-excitation décrivent des fonctions de protection psychique, sans désigner une barrière anatomique.

Les six réactions développées dans le cours sont sidération, déni, révolte ou colère, marchandage, dépression et acceptation. Elles ne sont ni obligatoires, ni toujours successives, ni limitées à un calendrier commun. La figure du support évoque ensuite le réinvestissement ; il s'agit d'un engagement possible, sans imposer une septième étape universelle.

Accompagner sans exiger l'acceptation

La personne peut avoir besoin de temps, reprendre une question ou revenir sur une émotion. L'infirmier observe et écoute ce qu'elle a compris et vécu, respecte son rythme et travaille avec l'équipe. Une réaction de défense momentanée peut protéger ; rechercher trop vite une acceptation attendue risquerait de fermer le dialogue.

Consigne annoncée

Dans l'analyse d'un témoignage, situer l'annonce comme événement et définir le concept en entier. Citer une réaction comme la sidération ou l'acceptation ne suffit pas à la rendre autonome : expliquer à quoi elle se rapporte et ce qui, dans le récit, permet de la retenir.

Notion	Point central
Identité corporelle	Sentiment de continuité et d'appartenance de ce corps à soi, inscrit dans son histoire et son rapport aux autres.

Le cours évoque les travaux sur le stade du miroir, la reconnaissance de soi et le regard d'autrui, puis les bouleversements de l'image corporelle pouvant accompagner des atteintes physiques, une alopécie, une chirurgie ou un handicap.

SITUATION CLINIQUE

À propos d'une modification corporelle, distinguer ce qui change objectivement (capacités, intégrité corporelle) et ce qui change subjectivement (image, honte, identité, confiance, relations). Éviter de minimiser les pertes ressenties par le patient.

Perturbations du schéma corporel et approche psychosomatique

Le cours distingue les atteintes du **schéma corporel**, souvent associées à des lésions ou dysfonctionnements neurologiques, des souffrances liées à l'**image du corps**. Après une amputation, une personne peut continuer à percevoir le membre absent et ressentir une douleur de membre fantôme. Des troubles tels que l'asomatognosie, l'héminégligence ou certaines dyspraxies sont également évoqués comme repères cliniques.

L'**identité corporelle** articule les données du corps réel (schéma corporel) et du corps imaginaire (image du corps). Une intervention mutilante ou une transformation visible peut nécessiter un travail de reconstruction de l'image et du rapport à autrui. Le cours souligne qu'on ne soigne pas seulement un organe : on accompagne une personne qui souffre d'une atteinte corporelle.

L'**approche psychosomatique** cherche à prendre en compte la relation entre psychisme et fonctionnement corporel dans une vision globale de la maladie. Le support souligne une précaution essentielle : une hypothèse d'influence psychique ne permet pas de conclure que le patient se serait rendu malade par sa pensée, ni de remplacer la recherche médicale d'une cause organique.

PRUDENCE ESSENTIELLE

Ne pas transformer l'approche psychosomatique en diagnostic de complaisance ni culpabiliser le patient. Le cours invite à reconnaître les dimensions psychosociales et somatiques sans déclarer comme prouvée une causalité psychique non établie.

11 · Méthode de mobilisation des concepts à l'examen

Le cours annonce une évaluation fondée sur l'analyse d'un **témoignage de patient**. La qualité de la copie ne repose pas sur l'énumération de notions, mais sur leur identification, la définition rédigée en entier et une justification à partir d'indices concrets.

Étape	Réflexe à adopter
1 · Observer	Relever les paroles du patient et les faits explicites sans extrapoler.
2 · Repérer	Sélectionner les concepts effectivement présents : représentations, qualité de vie, contrôle perçu, coping, soutien, défense, image du corps…

Corps vécu, construction de soi et psychosomatique

Le corps peut être appréhendé comme objet observé et soigné, et comme corps sujet, vécu de l'intérieur. La conscience de soi se construit dans les sensations, les mouvements, le langage et les relations. Les repères d'âge illustrent un développement ; ils ne suffisent pas à poser un diagnostic.

Notion	Construction et sens
Schéma corporel	Organisation sensorimotrice du corps dans l'espace. Il se construit avec la maturation et l'expérience, par intégration d'informations extéroceptives, proprioceptives et intéroceptives, des mouvements et des échanges. Il n'est pas donné d'emblée sous une forme achevée.
Somatotopie	Représentation organisée des parties du corps ; la taille d'une représentation corticale ne correspond pas à la taille réelle de la partie corporelle.
Image du corps	Représentation subjective, affective et sociale, consciente et inconsciente. Elle est personnelle et peut fluctuer avec le vécu et le regard d'autrui. Elle ne se réduit pas à la silhouette objective.
Identité corporelle	Articulation des repères du schéma corporel et de l'image du corps dans le sentiment d'être soi. Une atteinte corporelle peut demander une réorganisation de ces deux dimensions.

Le cours présente trois temps de la reconnaissance dans le miroir : prendre l'image pour un autre réel, comprendre qu'il s'agit d'une image, puis se reconnaître comme soi. La nomination et la relation à l'autre participent à cette construction ; le miroir n'est pas une simple mesure de perception visuelle.

Une même atteinte, plusieurs dimensions

Après une amputation, les appuis, les mouvements et les repères sensorimoteurs concernent le schéma corporel. Le sentiment d'être regardé, désirable ou reconnaissable concerne l'image du corps. Écouter les deux dimensions aide à comprendre la reconstruction identitaire ; une modification visible et un sentiment d'altération ne sont pas équivalents.

Psychosomatique : conserver une approche globale

Les relations entre vécu psychique et manifestations corporelles sont complexes. Une hypothèse psychosomatique ne se déduit pas de la seule absence d'explication lésionnelle et ne rend pas les symptômes simulés. Elle ne permet pas d'affirmer qu'une émotion a causé un cancer, ni de rendre la personne coupable de sa maladie. Les développements psychopathologiques relèvent d'autres enseignements.

Étape	Réflexe à adopter
3 · Définir	Donner une vraie définition en une ou plusieurs phrases complètes.
4 · Justifier	Rattacher précisément la notion à un passage du témoignage.
5 · Nuancer	Ne pas poser de diagnostic psychique à partir d'une phrase ; distinguer hypothèse et fait.

EXEMPLE DE RÉPONSE RÉDIGÉE

« Le patient cherche de l'aide auprès de sa famille et de ses soignants. Cela peut illustrer un soutien social mobilisé : il sollicite des ressources relationnelles pour faire face à une situation difficile. Il faut toutefois vérifier s'il perçoit ce soutien comme réellement disponible et aidant. »

12 · À retenir : connexions importantes

- La santé se comprend dans ses dimensions biologique, psychique et sociale ; la santé perçue reste une donnée subjective essentielle.
- Une maladie se décline en disease, illness et sickness : même diagnostic, vécus et conséquences très différents.
- Le modèle intégratif distingue prédicteurs, modérateurs transactionnels et issues ; les relations ne sont pas mécaniques.
- Le réseau social, le soutien reçu et le soutien perçu sont trois éléments différents.
- Vulnérabilité et résilience peuvent coexister ; la résilience mobilise des ressources internes et environnementales.
- Le stress s'appuie sur une double évaluation cognitive : signification de l'événement puis ressources pour y faire face.
- Les coping centrés sur le problème, les émotions ou la recherche de soutien sont des efforts d'ajustement contextualisés.
- Les mécanismes de défense sont largement inconscients et souvent protecteurs. L'affiliation défensive ne doit pas être confondue avec l'affiliation en psychosociologie.
- L'annonce du diagnostic peut faire choc, modifier l'identité et mobiliser coping et défenses.
- Le corps-objet et le corps-sujet ne résument pas la même réalité ; schéma corporel, image du corps et identité corporelle doivent être différenciés.

Repère oral : trois formes d'angoisse en psychanalyse

Morcellement : angoisse archaïque et massive de destruction, d'annihilation ou de mort psychique ; la personne peut avoir le sentiment que son identité vole en éclats ou que son corps part en morceaux.

Séparation, abandon, perte d'objet : peur de perdre un objet d'amour, c'est-à-dire un lien avec une personne investie affectivement. Cette angoisse peut exister sans abandon réel.

Castration : angoisse liée à des pertes symboliques qui touchent le sentiment de puissance ou de complétude ; par exemple, la crainte de ne pas être à la hauteur d'un examen.

Ces repères théoriques ne permettent pas de poser un diagnostic à partir d'une phrase.

Appliquer les notions à un témoignage

Les consignes annoncées privilégient des définitions intégrales, rédigées en phrases complètes, puis une justification précise. Il faut choisir les notions utiles au récit ; une récitation exhaustive sans lien avec les faits ne répond pas à l'analyse. Ne pas inventer de paroles pour compléter un témoignage.

Raisonnement	Vérification avant de conclure
Partir de la définition générale	Douleur avant douleur chronique ; souffrance avant souffrance psychique ; coping avant sa forme et sa sous-dimension. Conserver les conditions et la fin des définitions.
Distinguer situation et évaluation	Un diagnostic ou une intervention peuvent être stressants ; le stress perçu suppose une évaluation exprimée par la personne.
Distinguer ressources et appréciation	Une famille présente constitue un élément du réseau ; le soutien perçu exige une appréciation de disponibilité ou de satisfaction.
Dater l'événement	Identifier l'annonce ou le changement ponctuel au lieu de qualifier toute une maladie prolongée d'événement unique.
Distinguer émotion et ajustement	Nommer une peur ou une colère, puis rechercher les efforts cognitifs ou comportementaux pour y faire face.
Nuancer l'interprétation	Une parole ne suffit pas à diagnostiquer un mécanisme, un trait de personnalité ou une structure psychique ; revenir à la définition et aux indices disponibles.

Exemple d'entraînement construit

« Depuis l'annonce lundi, je pense que je ne pourrai pas gérer les soins. Ma sœur vient souvent, mais je n'ose pas lui demander de l'aide. J'ai préparé mes questions pour le rendez-vous. » L'annonce est un événement datable ; l'évaluation de ses capacités éclaire le stress perçu ; la présence de la sœur ne prouve pas un soutien perçu satisfaisant ; préparer des questions peut correspondre à un coping centré sur le problème par recherche d'informations.

Cet exemple est une situation pédagogique construite, pas une citation de patient ni une question annoncée au partiel. Une réponse rédigée donne la définition du concept retenu, cite l'indice correspondant et explique le lien, en indiquant ce qui reste inconnu.

Dernière vérification

Ai-je défini le concept en entier ? Ai-je justifié son application ? Ai-je gardé la distinction entre risque et certitude, modèle théorique et diagnostic, événement et vécu ? Les pièges regroupés et la synthèse qui suivent permettent une dernière relecture avant le lexique.

13 · Pièges QCM et confusions à éviter

Confusion fréquente	Correction attendue
Soutien social = uniquement aide reçue	Le soutien social général comprend aussi l'aide donnée. Ne pas confondre aide reçue et soutien perçu.
Réseau social étendu = soutien efficace	La qualité et la disponibilité perçue peuvent différer du nombre de relations.
Coping = mécanisme de défense	Le coping désigne des stratégies d'ajustement cognitives et comportementales ; les défenses sont surtout inconscientes.
Toute réaction de déni est néfaste	Le déni peut être momentanément protecteur ; l'enjeu est son intensité, sa rigidité et le risque réel.
Affiliation = même définition partout	En psychologie de la santé : mécanisme de défense. En psychologie sociale : lien / appartenance, étudié séparément.
Résilience = absence de traumatisme	Il y a eu épreuve ; le processus permet de poursuivre une construction malgré l'adversité.
Annonce = simple transmission de faits	Inclure choc psychologique, épreuve et effets sur l'identité et les proches.
Schéma corporel = image du corps	Schéma : repères sensorimoteurs ; image : représentation subjective et affective.
Diagnostic biologique = vécu personnel	Distinguer disease, illness et sickness.
Définition abrégée = réponse complète	L'enseignante exige des formulations grammaticales complètes ; les mots-clés seuls ne suffisent pas.

14 · Synthèse générale — L'essentiel du cours

La psychologie de la santé éclaire la personne au-delà du diagnostic : elle étudie le vécu singulier, les représentations de la maladie, les conditions de vie, le soutien social et les ressources permettant de faire face à une épreuve. La santé est globale, dynamique et subjective ; la maladie se comprend à la fois comme réalité biologique, expérience personnelle et événement social.

Les trajectoires dépendent de facteurs personnels et environnementaux, modulés par l'évaluation cognitive, le contrôle perçu, le soutien perçu et les stratégies de coping. La vulnérabilité ne condamne pas au trouble et la résilience est une construction au croisement de l'individu et de son environnement. Face à l'angoisse ou au choc d'un diagnostic, les mécanismes de défense peuvent protéger momentanément ; le soignant les observe et les respecte lorsqu'ils ne mettent pas en danger la personne.

Pour l'évaluation, le réflexe est constant : **repérer dans le témoignage → nommer précisément le concept → en donner la définition intégrale → montrer quels faits le justifient → nuancer l'interprétation**.

15 · Définitions et mots-clés

Les 59 formulations complètes sont conservées pour une restitution orale ou écrite. Les mots-clés seuls ne remplacent pas une définition précise.

01 · Psychologie de la santé

La psychologie de la santé applique les connaissances psychologiques à l'étude de la santé et de la maladie et cherche à comprendre comment les facteurs biologiques, psychologiques, sociaux et comportementaux interviennent dans la prévention, le maintien de la santé, le vécu et l'évolution des problèmes de santé.

02 · Santé — définition OMS citée

La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité.

03 · Santé perçue

La santé perçue est l'appréciation globale qu'une personne porte elle-même sur son propre état de santé, en intégrant ses sensations, son fonctionnement, ses repères et sa situation.

04 · Qualité de vie

La qualité de vie est la perception qu'un individu a de sa place dans l'existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lequel il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes.

05 · Approche biopsychosociale

L'approche biopsychosociale considère que la santé et la maladie résultent d'interactions entre des dimensions biologiques, psychologiques et sociales, et qu'aucune de ces dimensions ne suffit seule à résumer la situation de la personne.

06 · Disease

Le terme disease désigne la dimension biomédicale de la maladie, c'est-à-dire l'atteinte, les mécanismes et les signes objectivables étudiés par la médecine.

07 · Illness

Le terme illness désigne l'expérience subjective de la maladie, c'est-à-dire la manière dont une personne ressent, interprète et vit ce qui lui arrive.

08 · Sickness

Le terme sickness désigne la dimension sociale de la maladie, c'est-à-dire la manière dont un trouble est reconnu, interprété et traité dans l'environnement culturel, familial et social.

15 · Définitions et mots-clés — suite

09 · Douleur — formulation historique IASP 1979

La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle, ou décrite en des termes évoquant une telle lésion ; le cours souligne sa dimension personnelle et le fait qu'une lésion objectivable n'est pas indispensable à son existence.

10 · Plainte

La plainte est l'expression adressée à autrui d'un trouble, d'une gêne, d'une douleur ou d'une souffrance, telle que la personne la perçoit et peut la mettre en mots ou en comportements.

11 · Représentations de la maladie

Les représentations de la maladie sont les croyances et explications personnelles, souvent implicites, qu'un individu construit concernant la cause, l'identité, la durée, les conséquences et les possibilités de contrôle ou de traitement de sa maladie.

12 · Théorie profane

Une théorie profane est une explication personnelle de la maladie élaborée par la personne malade ou son entourage, à partir de leurs expériences, de leurs valeurs et de leurs croyances, indépendamment de la validité médicale de cette explication.

13 · Facteur de risque

Un facteur de risque est une caractéristique ou une situation associée à une probabilité plus élevée de rencontrer un problème de santé ; sa présence ne suffit pas, à elle seule, à déterminer l'apparition d'une maladie.

14 · Facteur de protection

Un facteur de protection est une caractéristique individuelle ou environnementale qui contribue à réduire un risque ou à favoriser les ressources d'adaptation face à une situation défavorable.

15 · Facteur salutogène

Un facteur salutogène est un élément personnel, relationnel ou environnemental qui favorise le maintien de la santé, le bien-être ou les capacités d'ajustement d'une personne.

16 · Soutien social — sens général

Le soutien social renvoie à l'ensemble des aides que des individus dispensent et reçoivent de leur entourage familial, amical, de voisinage ou institutionnel. Il comprend des formes diverses d'aide matérielle, informationnelle, morale ou affective.

17 · Réseau social

Le réseau social est l'ensemble des personnes avec lesquelles un individu est en relation.

15 · Définitions et mots-clés — suite

18 · Soutien social reçu

Le soutien social reçu désigne les caractéristiques observables et les aides effectivement reçues d'autrui, que l'on peut décrire notamment par les relations et ressources présentes dans l'entourage de la personne.

19 · Soutien social perçu

Le soutien social perçu correspond à l'appréciation subjective que la personne porte sur la disponibilité, la pertinence et la qualité de l'aide qu'elle pense pouvoir recevoir de son entourage.

20 · Vulnérabilité

La vulnérabilité se définit par un état de moindre résistance aux nuisances et agressions ; ce concept évoque des faiblesses patentes ou latentes, immédiates ou différées, et peut être compris comme une incapacité ou une difficulté à résister aux contraintes de l'environnement.

21 · Résilience — approche psychologique générale

En psychologie, la résilience désigne globalement un processus qui permet de sortir vainqueur d'une épreuve traumatique et de continuer à se construire malgré l'adversité ; elle suppose récupération après un traumatisme, réorganisation psychique et transformation à travers les épreuves.

22 · Résilience — Rutter (1985)

Capacité pour des individus ayant subi des événements de vie très aversifs, ou même dramatiques, d'arriver à mener une vie normale. Les sujets résilients sont capables de développer, dans des circonstances parfois très difficiles, des stratégies d'ajustement adéquates qui les protègent.

23 · Résilience — Boris Cyrulnik

La résilience définit la capacité à se développer quand même, dans des environnements qui auraient dû être délabrants.

24 · Personnalité

La personnalité désigne l'organisation relativement durable des manières de percevoir, de ressentir, de penser et de se comporter qui contribuent à la singularité d'un individu.

25 · Hostilité

L'hostilité regroupe des dimensions cognitives, émotionnelles et comportementales telles que le cynisme, les attributions hostiles, la colère, la méfiance et les réactions agressives.

26 · Stress transactionnel

Le stress signifie ici une relation entre la personne et son environnement, qui est évaluée par la personne comme tarissant ou excédant ses ressources et menaçant son bien-être.

15 · Définitions et mots-clés — suite

27 · Évaluation primaire

L'évaluation primaire est l'opération cognitive par laquelle une personne détermine ce que représente une situation pour elle, notamment une menace, une perte ou un défi.

28 · Évaluation secondaire

L'évaluation secondaire est l'opération cognitive par laquelle une personne apprécie les ressources et les possibilités d'action qu'elle estime disposer pour faire face à une situation.

29 · Contrôle perçu

Le contrôle perçu correspond à la représentation que se fait une personne de sa possibilité d'agir sur un événement, ses causes, son déroulement, ses conséquences ou ses propres réactions.

30 · Coping / stratégies d'ajustement

Le coping désigne les efforts cognitifs et comportementaux qu'une personne met en œuvre pour faire face à une situation évaluée comme stressante ou dépassant ses ressources habituelles.

31 · Coping centré sur le problème

Le coping centré sur le problème vise à réduire les exigences de la situation et/ou à augmenter ses propres ressources pour mieux y faire face, notamment par la recherche d'informations, la résolution de problèmes, la planification et l'action directe.

32 · Coping centré sur l'émotion

Le coping centré sur l'émotion vise à gérer les réponses émotionnelles induites par la situation, en détournant son attention, en réinterprétant positivement l'événement, en minimisant les conséquences ou en évitant temporairement la situation.

33 · Coping centré sur le soutien social

Le coping centré sur la recherche de soutien social rassemble les efforts effectués pour obtenir la sympathie, l'écoute, les informations ou l'aide matérielle et pratique d'autrui.

34 · Angoisse

L'angoisse est une peur sans objet, ou du moins sans objet extérieur défini, qui exprime la souffrance de l'appareil psychique face à une menace intérieure. Elle peut signaler un débordement et déclencher des mécanismes de défense.

35 · Mécanismes de défense

Les mécanismes de défense sont produits de manière inconsciente ; ils regroupent ce que le psychisme met en place lorsque la réalité est insupportable, afin de se protéger contre l'angoisse et de maintenir un certain équilibre. Face à un événement traumatique, ils peuvent laisser à la personne du temps pour intégrer ce qu'elle vit.

15 · Définitions et mots-clés — suite

36 · Déni

Le déni est l'action de refuser la réalité d'une perception vécue comme dangereuse ou douloureuse pour le moi.

37 · Projection

La projection est une opération par laquelle le sujet expulse dans le monde extérieur des pensées, des affects ou des désirs qu'il méconnaît ou refuse en lui et qu'il attribue à d'autres personnes ou choses de son environnement.

38 · Projection agressive

La projection agressive peut se manifester par des réactions agressives et revendicatrices du patient, sous forme de reproches, de plaintes ou d'insatisfaction orientés vers l'extérieur face à la maladie.

39 · Régression

La régression constitue un retour à des modes d'expression antérieurs de la pensée, des conduites ou des relations objectales, face à un danger interne ou externe susceptible de provoquer un excès d'angoisse ou de frustration.

40 · Rationalisation

La rationalisation est une justification logique, mais artificielle, qui camoufle, à l'insu de celui qui l'utilise, les vrais motifs irrationnels et inconscients de certains de ses jugements, conduites ou sentiments, car ces motifs ne pourraient être reconnus sans anxiété.

41 · Refoulement

Le refoulement est le rejet dans l'inconscient de représentations conflictuelles qui demeurent actives tout en étant inaccessibles à la prise de conscience. Le retour du refoulé peut intervenir lorsque le refoulement échoue ou devient insuffisant.

42 · Déplacement

Le déplacement est la généralisation ou le déplacement d'un problème vers un autre objet habituellement moins menaçant : l'affect et le sentiment restent reconnus et exprimés, mais ils sont redirigés vers une cible moins conflictuelle, bien que de même nature.

43 · Isolation

L'isolation désigne une élimination de l'affect lié à une représentation conflictuelle (souvenirs, idées ou pensées), alors que la représentation en question reste consciente.

44 · Dénégation

La dénégation est le refus de reconnaître comme siens, immédiatement après les avoir formulés, une pensée, un désir ou un sentiment qui sont source de conflit.

15 · Définitions et mots-clés — suite

45 · Maîtrise

La maîtrise vise à diminuer l'angoisse liée à l'incertitude de la maladie à travers la restauration d'un sentiment de contrôle sur la situation ; la personne veut agir sur sa propre histoire et sur la maladie en croyant pouvoir en contrôler le processus.

46 · Retrait apathique

Le retrait apathique est un détachement protecteur, fait d'indifférence affective, de restriction des relations sociales et des activités extérieures, et de soumission passive aux événements, qui permet à une personne de supporter une situation très difficile.

47 · Activisme

L'activisme consiste à gérer les conflits psychiques ou les situations traumatiques externes par le recours à l'action, à la place de la réflexion ou du vécu des affects.

48 · Combativité

La combativité est une forme d'activisme qui neutralise l'angoisse et le désarroi du malade en suscitant une énergie importante lui permettant de dépasser la maladie et de se dépasser lui-même.

49 · Affiliation — mécanisme de défense

L'affiliation est la recherche de l'aide et du soutien d'autrui quand on vit une situation qui engendre de l'angoisse. Dans ce chapitre, elle désigne un mécanisme de défense, et non le concept distinct d'affiliation en psychologie sociale.

50 · Humour — mécanisme de défense

L'humour est un processus qui consiste à présenter une situation vécue comme traumatisante de manière à en dégager les aspects plaisants, ironiques ou insolites. C'est uniquement l'humour appliqué à soi-même qui peut être considéré comme un mécanisme de défense.

51 · Sublimation

La sublimation peut renvoyer à la désexualisation d'une pulsion qui se transforme en tendresse ou en amitié sans changer d'objet ; elle peut aussi désigner la dérivation de l'énergie d'une pulsion sexuelle ou agressive vers des activités socialement valorisées, notamment artistiques, intellectuelles ou morales.

52 · Annonce du diagnostic

L'annonce du diagnostic est l'acte médical par lequel un médecin fait part à un patient du diagnostic d'une pathologie aiguë ou chronique, ou d'un handicap. L'annonce du diagnostic est toujours un choc psychologique, une épreuve, un bouleversement et un traumatisme pour le patient et ses proches, au sens où cette annonce fait effraction dans le psychisme.

15 · Définitions et mots-clés — suite

53 · Approche psychosomatique

L'approche psychosomatique est une approche clinique globale qui cherche à relier les dimensions psychiques et somatiques de la personne, en tenant compte de son histoire, de ses relations et de ses conditions de vie, sans réduire une maladie à une cause uniquement mentale.

54 · Douleur du membre fantôme

La douleur du membre fantôme est une douleur que la personne peut ressentir comme provenant d'un membre amputé, bien que ce membre ne soit plus présent ; elle illustre les perturbations possibles du vécu et des représentations corporelles.

55 · Corps-objet

Le corps-objet désigne le corps que la médecine peut observer et étudier scientifiquement, notamment par l'anatomie, la physiologie et l'étude de ses organes.

56 · Corps-sujet

Le corps-sujet est le corps singulier vécu par la personne, indissociable du psychisme, du langage, de son histoire et de sa relation à autrui.

57 · Schéma corporel

Le schéma corporel est l'organisation des repères sensoriels, moteurs et posturaux qui permet à une personne de se situer, de percevoir et de mobiliser son corps dans l'espace et dans l'action.

58 · Image du corps

L'image du corps est la représentation subjective, psychique et affective qu'une personne construit de son propre corps, de son apparence et de sa valeur corporelle au regard de son histoire et des relations avec autrui.

59 · Identité corporelle

L'identité corporelle désigne le sentiment d'être soi dans et avec son corps et de conserver une continuité de soi malgré les transformations, les expériences et les perceptions corporelles.

Définitions et mots-clés — compléments aux 59 définitions

Les définitions 01 à 59 de la fiche antérieure sont intégralement conservées. Les suivantes précisent des notions présentes dans les documents officiels.

60 · Maladie chronique

Une maladie chronique est une affection rarement guérissable qui nécessite une prise en charge prolongée, souvent durable, afin d'en limiter les effets, d'en compenser certaines conséquences ou d'en accompagner l'évolution.

61 · Douleur chronique

Une douleur chronique est une douleur qui persiste ou réapparaît pendant plus de trois mois ; elle est multifactorielle et peut associer des dimensions biologiques, psychologiques et sociales.

62 · Souffrance psychique

La souffrance psychique est un état de mal-être qui peut survenir dans une situation éprouvante sans remplir nécessairement les critères d'un trouble psychiatrique caractérisé.

63 · Événement de vie

Un événement de vie est un changement extérieur à la personne, relativement rapide et suffisamment important pour créer une discontinuité dans son existence et mobiliser ses capacités d'adaptation.

64 · Difficulté de vie

Une difficulté de vie est une situation problématique persistante durant au moins quatre semaines.

65 · Tracas quotidiens

Les tracas quotidiens sont des incidents ou difficultés de faible intensité qui, par leur fréquence ou leur accumulation, peuvent participer à la charge de stress ressentie.

66 · Échelle de Holmes et Rahe

L'échelle de Holmes et Rahe est un outil historique qui attribue un poids de réajustement à différents événements de vie pour estimer une charge de changements ; son score ne permet pas de prédire avec certitude l'apparition d'une maladie chez une personne.

67 · Type de personnalité A

Le type A désigne, dans les modèles historiques présentés, un profil marqué notamment par l'impatience, la compétitivité et parfois l'hostilité ; les associations avec la maladie coronarienne ont été discutées et nuancées.

68 · Type de personnalité C

Le type C renvoie à un profil d'adaptation historiquement décrit par l'inhibition des émotions négatives et la conciliation ; son association supposée au cancer ne constitue pas une causalité médicale démontrée.

69 · Optimisme

L'optimisme est une tendance cognitive relativement générale à anticiper des issues favorables et à percevoir positivement les possibilités futures.

70 · Lieu de contrôle

Le lieu de contrôle correspond à la croyance générale que les événements dépendent principalement de facteurs internes, liés à ses actions, ou de facteurs externes, comme le hasard et l'influence d'autrui.

71 · Auto-efficacité

L'auto-efficacité est la croyance qu'une personne peut mobiliser ses ressources et conduire les actions requises pour réussir une tâche ou surmonter une situation.

Définitions et mots-clés — notions générales

Ces deux notions générales permettent de définir avant de préciser une forme particulière. Elles complètent les définitions précédentes et doivent être restituées en phrases entières.

72 · Maladie

La maladie est une altération de la santé comportant un ensemble de caractères définis : une cause, des signes et des symptômes, une évolution et des modalités thérapeutiques et pronostiques précises.

73 · Souffrance

La souffrance qualifie un être qui supporte, endure ou subit une douleur physique et morale, un état de mal-être, c'est-à-dire un sentiment de non-adaptation au monde, d'étrangeté aux êtres et aux choses, d'indifférence douloureuse.

L'explication du cours précise que douleur physique et souffrance morale peuvent être associées ou exister séparément. La souffrance ne se réduit pas à une sensation locale et peut comporter des dimensions corporelles, psychiques, émotionnelles, existentielles et morales.

> **Ordre de restitution**
>
> La définition générale précède la définition de la forme chronique ou psychique. La douleur historique de l'IASP 1979 reste identifiée comme telle dans le lexique ; la formulation IASP 2020 est distinguée dans le développement du cours.